

List do osoby bliskiej

Karta dla partnera, rodzica, przyjaciela. Co rozpoznawać, jak reagować, czego nie robić, kiedy zadziałać. Wręcz tej osobie razem z planem kryzysowym.

CZAS: 30 min · wspólna rozmowa Aktualizuj po każdym epizodzie

ŹRÓDŁO: Miklowitz (2008, FFT); Sajatovic

JAK UŻYWAĆ

Ten list jest skierowany do **osoby, która Ci pomaga** — partnera, rodzica, dziecka, przyjaciela. Ona/on otrzymuje go od Ciebie w eutymii. Karta wyjaśnia: jak rozpoznać Twoją manię/hipomanię, jak reagować (3 zasady), czego unikać (3 zasady), kiedy działać natychmiast, jak rozmawiać po epizodzie. Wypełnij z tą osobą wspólnie — punkty osobiste (sygnały, telefony, decyzje) są kluczowe. Daj kopię tej osobie, jedną zachowaj.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Terapia rodzinno-skupiona FFT (Miklowitz 2008) w meta-analizach należy do najbardziej skutecznych dodatków do farmakoterapii ChAD. W randomizowanym badaniu Miklowitz i wsp. (2003) pacjenci, których rodziny przeszły 21-sesijną FFT, mieli **35% mniej nawrotów** w 2-letniej obserwacji i **krótsze hospitalizacje**. Mechanizm: **obniżenie wysokiej emocjonalności wyrażanej** w rodzinie (krytycyzm, nadmierne zaangażowanie emocjonalne) plus **współpraca** w rozpoznawaniu sygnałów. Ten handout to skondensowany element FFT — do wdrożenia bez konieczności pełnej terapii.

01 Wstęp — od osoby z ChAD (do uzupełnienia)

Drogi/a _____,

Mam chorobę afektywną dwubiegunową. To znaczy, że doświadczam epizodów manii lub hipomanii (zwiększonej energii) i depresji. Wiem, że dla Ciebie też jest to trudne — szczególnie kiedy w hipomanii zachowuję się tak, jakby wszystko było *w porządku*, a Ty widzisz, że nie jest.

Pisząc ten list w spokojnym czasie, daję Ci **narzędzia, które mogą pomóc nam obojgu** — gdy nadchodzi kolejny epizod. Daję Ci też pozwolenie na pewne działania, których w hipomanii bym Ci nie dał/a sam/a.

Twoja pomoc nie jest opcjonalna. Jesteś jedną z najważniejszych osób w moim leczeniu.

Z wdzięcznością,

_____ (podpis) data: _____

02 Sygnały, które u mnie poprzedzają epizod manii

Wypełnij wspólnie. Osoba bliska często zauważa Twoje sygnały *wcześniej niż Ty sam/a*.

CO WIDZĘ, JA SAM/-A

CO WIDZISZ TY

03 ✓ Co robić — trzy zasady

1 • POWIEDZ MI WPROST

„Zauważam, że *śpisz mało* i *jesteś rozkojarzony/-a*. Czy sprawdziłaś/-eś wykres nastroju?”
— **opisz konkretne zachowanie**, nie etykietuj („wpadasz w manię”).

2 • POMÓŻ MI ZWOLNIĆ

Wspólne spokojne aktywności: powolny spacer, posiłek, wieczór bez ekranów. Zaproponuj, nie nakazuj. **Bądź obecny/-a** — sama obecność wycisza.

3 • DZIAŁAJ ZGODNIE Z PLANEM

Karta planu kryzysowego mówi, kiedy zadzwonić do lekarza i co zrobić. **Nie improwizuj** — wykonaj kolejne kroki. Plan został zrobiony w eutymii — ufaj mu.

04 ✗ Czego nie robić — trzy zasady

1 • NIE KLÓCIĆ SIĘ

W hipomanii pacjent *nie zostanie przekonany racjonalnie*. Argumentowanie eskaluje pobudzenie. Powiedz raz, spokojnie. Nie wracaj 5 razy do tego samego argumentu.

2 • NIE OBWINIAĆ

„Znowu się zaczyna twoja głupota” lub „specjalnie to robisz” są *niezasadne* i bardzo bolesne. To choroba, nie wybór. Trzymaj się **opisu zachowania**, nie etykiet osoby.

3 • NIE ZWLEKAĆ Z LEKARZEM

„Może samo przejdzie” — zwykle nie przechodzi, eskaluje. Jeśli plan kryzysowy mówi „dzwoń przy 3 sygnałach” — dzwoń **nawet jeśli ja się nie zgadzam** (mam Twoje pozwolenie).

05 ☉ Kiedy działaj natychmiast (mam Twoje pozwolenie)

- ☐ Sen poniżej 4 h przez 2 noce z rzędu
- ☐ Pojawiają się objawy psychotyczne (halucynacje, urojenia)
- ☐ Podejmuję ryzykowne decyzje finansowe (kupuję, inwestuję, sprzedaję)
- ☐ Tracę wgląd, kłócę się o leczenie, chcę odstawić leki
- ☐ Mówię o samobójstwie lub krzywdzeniu siebie

Wtedy: zadzwoń do mojego psychiatry — tel.: _____

Jeśli niedostępny: izba przyjęć psychiatryczna — adres: _____

W zagrożeniu życia: 112 lub 116 123

Daję Ci pozwolenie na: ☐ przejęcie kart płatniczych ☐ przejęcie kluczyków do auta ☐ kontakt z moim pracodawcą ☐ zabranie laptopa

Klucz: w 2-letnim badaniu Miklowitza i wsp. (2003) *rodziny z niską emocjonalnością wyrażaną* (mało krytyki, mało wrogości, mało nadopiekuńczości) miały **62% mniej nawrotów** u członka rodziny z ChAD w porównaniu z rodzinami wysokoekspresywnymi. To, jak osoba bliska *mówi i reaguje*, jest jednym z najsilniejszych modyfikowalnych czynników w przebiegu ChAD. Ten list to pierwszy krok do tego, by Twoja osoba bliska była częścią rozwiązania — nie obciążenia.